Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Portão

Rua Cuiabá, 145, Prédio - Bairro: Centro - CEP: 93180000 - Fone: (51)3098--5789 - Email: frportao1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004034-25.2022.8.21.0155/RS

AUTOR: DORACI ANA DA SILVA

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

DORACI ANA DA SILVA ajuizou **AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, partes já qualificadas. Narrou ter sido diagnosticada com **neoplasia maligna de mama metastática (CID C50.0)** em 2006 e que, atualmente, apresenta metástases ósseas. Afirmou que as alternativas terapêuticas padronizadas e disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já se encontram esgotadas para o seu quadro clínico, tornando o medicamento Succinato de Ribociclibe 200mg necessário para a melhora e controle da progressão da doença, sob iminente risco de agravamento do quadro e consequente óbito. Sustentou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do tratamento, que se revelam elevados, fundamentando seu pleito no direito fundamental à saúde, expressamente previsto no artigo 196 da Constituição Federal, bem como na responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde. Postulou, em sede de tutela de urgência e em caráter definitivo, o fornecimento do medicamento Succinato de Ribociclibe 200mg, comercialmente conhecido como KISQALI, na posologia de 3 comprimidos ao dia por 21 dias, em ciclos contínuos. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e juntou documentos.

Deferido o benefício da gratuidade de justiça à autora (evento 15, DESPADEC1).

O Juízo determinou a consulta ao sistema e-NatJus referente ao fármaco pleiteado (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio nota técnica favorável (evento 11, NOTATEC1).

O Estado compareceu de forma espontânea, apresentando justificação prévia (evento 14, PET1).

Foi deferida a tutela de urgência pretendida pela autora, determinando que a parte demandada disponibilizasse, periodicamente, o medicamento SUCCINATO DE RIBOCICLIBE na forma prescrita, sob pena de bloqueio de valores (evento 15, DESPADEC1).

Citado, o Estado apresentou contestação. Preliminarmente, reiterou a tese de sua ilegitimidade passiva e a imprescindibilidade da inclusão da União no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, fundamentando-se em interpretação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, o Estado discorreu sobre a organização da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, defendendo que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos de alta complexidade recai sobre a União, que repassa os valores diretamente aos centros habilitados (CACONs/UNACONs). Argumentou ainda sobre o elevado custo do tratamento e a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir indevidamente nas políticas públicas de saúde, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível, bem como de desorganização do planejamento orçamentário da saúde (evento 41, CONT1).

Houve réplica (evento 48, PET1).

Em saneamento, foram afastadas as preliminares suscitadas pelo réu. As partes foram intimadas para especificação de provas, oportunidade em que nada foi requerido (evento 50, DESPADEC1).

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pela procedência dos pedidos autorais (evento 59, PROMOÇÃO1).

Durante o trâmite processual, a autora informou o descumprimento da liminar, tendo sido efetivados bloqueios de valores em desfavor do réu. A parte autora prestou contas em todas as oportunidades, as quais foram devidamente homologadas.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito transcorreu regularmente, não há irregularidades a serem sanadas, sendo prescindível a produção de outras provas além daquelas já acostadas aos autos. Autorizado, portanto, o imediato julgamento do feito, no estado em que se encontra o processo, e estando presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em definir se há obrigação do ente estatal de fornecer à autora o medicamento Succinato de Ribociclibe 200 mg (Kisqali), na posologia de 3 comprimidos ao dia por 21 dias, em ciclos contínuos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, garantiu o direito à vida. Em seu artigo 6º, *caput*, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros.

O artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado de garantir esse direito mediante políticas sociais e econômicas. A Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o Sistema Único de Saúde e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos pela via judicial, por meio dos Temas nºs 1.234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo transcritas:

> ***Súmula Vinculante 60:*** *O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> ***Súmula Vinculante 61:*** *A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Através da edição o Tema nº 06, o STF fixou a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

> *(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;*
>
> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*
>
> *(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*
>
> *(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e*
>
> *(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento*

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso concreto.

Segundo laudo médico acostado aos autos (evento 1, LAUDO9), a autora é portadora de neoplasia maligna da mama (CID 10 C50.9), necessitando do uso do medicamento Ribociclibe.

A sra. Doraci Ana da Silva teve diagnóstico de carcinoma de mama em 2006.. Na época foi operada e iniciou tratamento adjuvante com Tamoxifeno completando 05 anos em 2012. Em 2015 apresentou recidiva local , foi a mastectomia e iniciou tratamento adjuvante com Anastrazol por mais 05 anos.Em 2021 iniciou com dor óssea e investigação mostrou metástases ósseas. Biópsia de lesão em fêmur foi de um adenocarcinoma metastáico com primário em mama. Imunohistoquímica com positividade para receptores hormonais(RE/RP) , negatividade para HER2 e ki 67 15%(Luminal A). Como paciente não está em crise visceral, o tumor tem perfil Luminal , ki 67 baixo, paciente ter ficado quase 10 anos em tratamento homonioterápico (Tamoxifeno e Anastrazol) com progressão tardia do carcinoma não foi optado iniciar tratamento sistêmico com quimioterapia, mas sim nova linha de hormonioterapia – primeira linha paliativa com Fi[ulvestranto e Ribociclibe pois a mesma deve ser uma boa respondedora a hormonioterapia em caráter paliativo evitando assim toda toxicidade da quimioterapia, pelo menos inicialmente.

O Estudo MONALEESA 3 avaliou Ribociclibe associado a Fulvestranto em 726 paciente com carcinoma de mama avançado ou metastático positivo para receptores hormonais e negativo para HER 2 sem tratamento prévio ou no máximo 01 linha de terapia prévia – quadro da paciente.

Neste estudo após 70,8 meses de acompanhamento de pacientes em primeira linha incluindo pacientes com " doença metastática de novo" ou " recidiva tardia", a sobrevida global mediana foi de 67,6 meses com RIBOCICLIBE mais FULVESTRANTO versus 51,8 meses com Fulvestranto sozinho (razão de risco = 0,67 ; intervalo de confiança = 0,50 – 0,90). Ribociclobe associado a Fulvestranto demonstrou sobrevida global mediana longa para uma população de primeira linha no câncer de mama avançado. Não apenas a sobrevida melhora, mas tambe´m os desfecho secundários, incluindo sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de quimioterapia e tempo para início de quimioterapia..

Uma análise atualizada se concentrou nos 365 pacientes tratados no cenário de primeira linha. O estudo descobriu que RIBOCICLIBE + FULVESTRANTO alcançou uma sobrevida global mediana de 67,6 meses em comparação com 51,8 meses para Fulvestranto isolado, resultando em uma redução de 33% na morte (HR = 0,673; IC 95%=0,504-0,899). Conseguimento prolongado, a taxa de sobrevida estimada em 5 anos foi de 56,5 vs 42,1. Além disso, 16,5% dos pacientes que receberam o tratamento duplo em comparaçao com 8,6% que receberam Fulvestranto sozinho ainda estavam em tratamento neste seguimento mais longo.

Levando em consideração o quadro clínico da sra. Doraci Ana da Silva podemos ver que a mesma apresenta perfil clínico e patológico que encaixam-se para o tratamento combinado de FULVESTRANTO com RIBOCICLIBE. Além disso, como informado acima, a mesma está sintomática , mas em ótimo estado geral e a hormonioterapia mantem a qualidade de vida devido a baixa toxicidade.

Referências

1. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al: Estudo randomizado de fase III de Ribociclibe e Fulvestranto , em câncer de mama avançado positivo para receptor hormonal, receptor do fator de crescimento epidermico humano 2 negativo: MONALEESA 3. J Clin Oncol 36:2465-2472,2018.

2. Slamo DJ, Neven P, Chia S, el al: Resultados atualizados de sobrevida global do Estudo de fase III MONALEESA 3 de pacientes na pós menopausa com câncer de mama avançado HR+ HER2- tratadas com Fulvestranto e Ribociclibe. Reunião Anual da ASCO 2021. Resumo 1001.Apresentado em 04 de junho de 2021.

Dra. Débora Cravo Bellesini
Oncologista
CRM - 10602

Requisitada nota técnica ao e-NatJus, sobreveio parecer favorável ao tratamento (evento 11, NOTATEC1), confirmando a adequação e necessidade do medicamento pleiteado para o quadro clínico da autora.

Conclusão

Tecnologia: SUCCINATO DE RIBOCICLIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: O medicamento teve parecer favorável à incorporação pelo SUS, mas paciente informa ausencia do medicamento no UNACOM onde realiza o tratamento e também indeferimento via esfera administrativa no SUS. O medicamento já deveria estar disponível no SUS para tratamento.
Portanto, há justificativa para um parecer técnico favorável ao medicamento pleiteado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Ademais, de acordo com a referida nota técnica, o SUS não dispõe de alternativas similares ao medicamento pleiteado, o que demonstra a impossibilidade de substituição terapêutica.

Assim, restou devidamente demonstrada pela parte autora a imprescindibilidade do fármaco postulado, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro medicamento disponível na rede pública.

Verifico, ainda, que houve avaliação pela CONITEC em relação ao fármaco postulado pela requerente para a patologia da autora, sendo recomendada sua incorporação ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de dezembro de 2021:

PORTARIA SCTIE/MS Nº 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Ref.: 25000.112928/2021-08, 0023990518.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, fica dispensada a análise do item "b" do Tema 6 do STF, uma vez que o medicamento já foi recomendado para incorporação pela CONITEC.

Há, ainda, negativa administrativa ao fornecimento do fármaco postulado pela autora (eevento 1, CERTNEG10), o que autoriza a via judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF.

Por fim, quanto à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento sem prejuízo de sua própria subsistência, verifica-se que a autora comprovou sua hipossuficiência econômica, litigando, inclusive, sob o amparo da gratuidade da justiça.

Assim, por todo o exposto, tenho que foram preenchidos os requisitos dos Temas 1234 e 06, merecendo acolhimento a pretensão da requerente no tocante à concessão do fármaco.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **?DORACI ANA DA SILVA** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, tornando definitivos os efeitos da decisão antecipatória de tutela (evento 15, DESPADEC1), determinando a concessão do medicamento Ribociclibe 200mg, na forma prescrita pelo médico assistente, enquanto necessário ao tratamento da saúde da autora.

O requerido vai isento das custas, nos termos da Lei Estadual 14.634/2014.

Condeno o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento das despesas processuais (isento da taxa única e de condução). Também condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC e Tema 1313 do STJ, que deverá ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Sentença publicada eletronicamente.

Partes intimadas.

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para o oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Da mesma forma, havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, no mesmo prazo.

Após, remetam-se os autos para o Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o artigo 1.010, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LIDIANE MACHADO DE OLIVEIRA, Juíza de Direito**, em 27/10/2025, às 18:45:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093611051v11** e o código CRC **563dcdca**.